

VAS OBSTRUÍDA — NÃO AGITAR, PREPARAR VIA CIRÚRGICA

CAUSAS DE OBSTRUÇÃO DE VIA AÉREA SUPERIOR

Grupo	Causas	Pista
Infeciosa	Epigloteite, abscesso retrofaríngeo/periamigdaliano, angina de Ludwig	Febre, disfagia, sialorreia, toxemia
Alérgica	Angioedema (anafilaxia, IECA), edema de glote	Início rápido, edema de lábios/língua, urticária
Corpo estranho	Bolo alimentar, prótese, objeto	Engasgo súbito durante a alimentação
Tumoral	Câncer de laringe/faringe, massa cervical	Estridor progressivo, rouquidão, perda de peso
Traumática	Trauma cervical, queimadura/inalação, pós-extubação	Histórico de trauma/incêndio; edema
Neuromuscular/funcional	Paralisia bilateral de cordas vocais, laringoespasma	Estridor, voz alterada

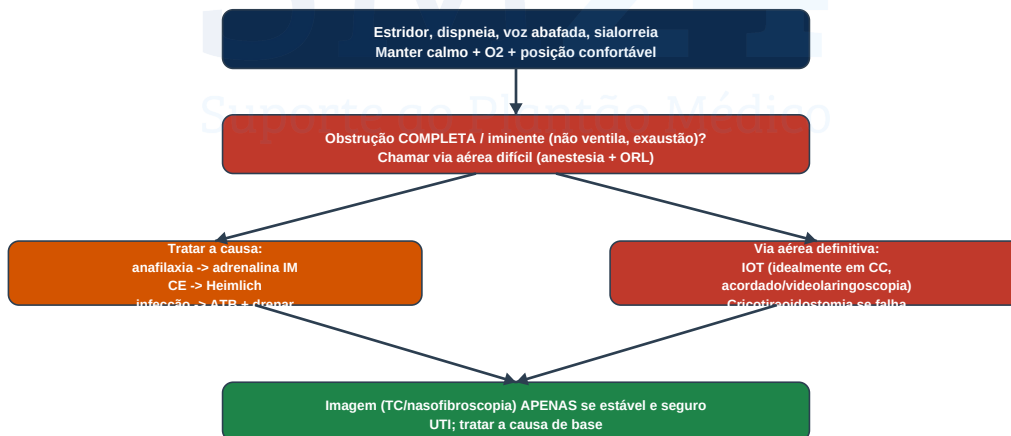
RECONHECER A GRAVIDADE E NÃO PIORAR

ESTRIDOR EM REPOUSO = OBSTRUÇÃO IMPORTANTE

- Estridor inspiratório, tiragem, uso de musculatura acessória, voz abafada, sialorreia e posição de tripé indicam obstrução significativa
- NÃO agitar o paciente nem examinar a garganta agressivamente (sobretudo na suspeita de epigloteite) — pode precipitar a obstrução total
- Manter o paciente sentado/confortável; oferecer O₂; ambiente calmo
- Chamar precocemente a equipe de via aérea difícil (anestesia + ORL/cirurgia) e PREPARAR via aérea cirúrgica (cricotireoidostomia)
- Anafilaxia/angioedema: adrenalina IM imediata; via aérea precoce se progressão
- Corpo estranho com obstrução completa (não fala, não tosse): manobra de Heimlich
- Plano A-B-C-D de via aérea difícil: se 'não intubo, não ventilo' -> via aérea cirúrgica

MANEJO DA OBSTRUÇÃO DE VAS

VAS — ESTÁVEL? CAUSA? PREPARAR VIA AÉREA



TRATAMENTO POR CAUSA

Causa	Tratamento específico
Anafilaxia / angioedema alérgico	Adrenalina IM (1a linha) + corticoide + anti-histamínico; via aérea precoce se progressão
Angioedema por IECA (bradicinina)	Suspender IECA; suporte de via aérea (responde mal a adrenalina/corticoide)
Epigloteite	Não examinar a garganta; via aérea no centro cirúrgico + ATB IV (ceftriaxona)
Abscesso (peritonsilar/retrofaringeo)	Drenagem + antibiótico; proteger a via aérea
Corpo estranho	Obstrução completa: Heimlich; remoção (laringoscopia/broncoscopia)
Tumor de laringe	Via aérea (traqueostomia se necessário) + avaliação oncológica

VIA AÉREA DIFÍCIL E ANGIOEDEMA

Princípios da Via Aérea Difícil • Antecipar a dificuldade e chamar ajuda (anestesia/ORL) precocemente • Preferir intubação no centro cirúrgico, com paciente acordado/videolaringoscopia quando possível • Ter o material e a equipe para via aérea cirúrgica (cricotireoidostomia) prontos • Cenário 'não intubo, não ventilo': cricotireoidostomia de emergência • Evitar sedação que abula o esforço respiratório antes de garantir a via aérea • Pré-oxigenar	Angioedema: Alérgico x IECA • Alérgico (histaminérgico): urticária, prurido, início rápido; responde a adrenalina/corticoide/anti-histamínico • Por IECA (bradicinérgico): edema de língua/lábios/glote, sem urticária; responde MAL às medidas alérgicas • IECA: suspender o fármaco; o foco é proteger a via aérea • Pode haver edema progressivo e tardio — observar • Considerar agentes específicos (icatibanto) no angioedema hereditário/por IECA conforme disponibilidade • Via aérea precoce se progressão do edema
---	--

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE ☐ Reconhecer a gravidade: estridor em repouso, tiragem, voz abafada, sialorreia, exaustão ☐ Manter o paciente calmo, sentado e com O2; NÃO agitar nem examinar a garganta agressivamente ☐ Chamar precocemente a equipe de via aérea difícil (anestesia + ORL) e preparar via cirúrgica ☐ Tratar a causa: adrenalina IM na anafilaxia; Heimlich no corpo estranho; ATB/drenagem na infecção ☐ Via aérea definitiva (idealmente em CC); cricotireoidostomia se 'não intubo, não ventilo' ☐ Imagem/nasofibroscopia só se o paciente estiver estável e seguro

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com estridor, voz abafada, sialorreia e posição de tripé, com suspeita de epiglote. Qual conduta é CONTRAINDICADA?

- A) Manter o paciente calmo e sentado
- B) Examinar agressivamente a orofaringe com abaixador de língua
- C) Oferecer oxigênio
- D) Acionar a equipe de via aérea difícil (anestesia + ORL)
- E) Preparar material para via aérea cirúrgica

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente em uso de IECA apresenta edema de língua e lábios, sem urticária, com dispneia progressiva. Qual a característica do tratamento?

- A) Responde muito bem à adrenalina e ao corticoide, como o alérgico
- B) É bradicinérgico, responde MAL às medidas alérgicas; suspender o IECA e priorizar a proteção da via aérea
- C) Não há risco de obstrução
- D) Deve-se manter o IECA
- E) Trata-se apenas com anti-histamínico oral

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Diante do cenário 'não intubo, não ventilo' em obstrução de via aérea superior, qual a conduta?

- A) Insistir indefinidamente na intubação orotraqueal
- B) Cricotireoidostomia de emergência (via aérea cirúrgica)
- C) Sedar profundamente e aguardar
- D) Apenas oxigênio por máscara
- E) Traqueostomia eletiva no dia seguinte

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual sinal indica obstrução significativa da via aérea superior?

- A) Tosse produtiva leve
- B) Estridor inspiratório em repouso com tiragem e uso de musculatura acessória
- C) Coriza
- D) Febre baixa isolada
- E) Espirros

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Adulto engasga durante a refeição e fica subitamente incapaz de falar ou tossir, com sinais de asfixia. Qual a conduta imediata?

- A) Oferecer água
- B) Manobra de Heimlich (compressões abdominais)
- C) Aguardar a tosse espontânea
- D) Tomografia de tórax
- E) Corticoide oral

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na suspeita de epiglotite/obstrução grave, examinar agressivamente a orofaringe com abaixador de língua é **CONTRAINDICADO** — pode desencadear laringoespasma e obstrução total. Mantém-se o paciente calmo, com O2, e prepara-se a via aérea com a equipe especializada.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O angioedema por IECA é mediado por bradicinina (não histaminérgico): cursa com edema de língua/lábios/glote sem urticária e responde **MAL** à adrenalina/corticoide/anti-histamínico. A conduta é suspender o IECA e priorizar a proteção da via aérea.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

No cenário 'não intubo, não ventilo', a conduta é a via aérea cirúrgica de emergência — a cricotireoidostomia — para garantir a oxigenação. Insistir na intubação ou apenas oferecer O2 leva ao desfecho fatal.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O estridor inspiratório em repouso, associado a tiragem e uso de musculatura acessória, indica obstrução significativa da via aérea superior e exige reconhecimento e preparo imediato para o manejo da via aérea.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Engasgo súbito com incapacidade de falar ou tossir e sinais de asfixia indica obstrução **COMPLETA** por corpo estranho — a conduta imediata é a manobra de Heimlich (compressões abdominais) para desobstruir a via aérea.

SM24
Suporte ao Plantão Médico